

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

ESCALA BREVE DE EVALUACIÓN PSIQUIÁTRICA (BPRS)

Brief Psychiatric Rating Scale (Overall & Gorham, 1962, 1988) · Adaptación Española (Bobes et al., 2004)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Escala Breve de Evaluación Psiquiátrica (Brief Psychiatric Rating Scale, BPRS)
Sigla / Acrónimo	BPRS (versión clásica de 18 ítems)
Autoría original	John E. Overall & Donald R. Gorham (1962, Psychol Rep; Overall, 1988)
Adaptación en español	Bobes García, García-Portilla, Bascarán, Sáiz et al. (2004, Ars Medica / CIBERSAM)
Constructo evaluado	Gravedad global y perfil dimensional de síntomas psicóticos, afectivos y conductuales en salud mental
Población diana	Pacientes adultos ingresados o ambulatorios con esquizofrenia, psicosis afectiva o trastorno bipolar
Tiempo de aplicación	15 a 25 minutos (heteroadministrada mediante entrevista clínica y observación directa)
Estructura y formato	18 ítems evaluados en escala Likert de 7 puntos con anclajes operativos (1 = no presente a 7 = extremadamente grave)
Condiciones de uso	Dominio público para práctica clínica e investigación no comercial citando a Overall & Gorham

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La BPRS es uno de los instrumentos clinimétricos más veteranos, consolidados y ampliamente empleados en la historia de la psiquiatría y la psicofarmacología clínica. Fue concebida por Overall y Gorham para proporcionar una evaluación estandarizada, rápida y altamente sensible al cambio en pacientes psiquiátricos mayores, superando la dispersión diagnóstica y permitiendo cuantificar la respuesta a los nuevos antipsicóticos.

El marco conceptual de la BPRS combina dos fuentes fundamentales de información: la exploración verbal semiestructurada de los síntomas subjetivos referidos por el paciente (ansiedad, vivencias alucinatorias, ideas delirantes, culpa) y la observación conductual no verbal directa del comportamiento durante la entrevista (retraimiento emocional, manierismos y posturas, enlentecimiento motor, falta de cooperación y afecto aplanado).

3. ESTRUCTURA FACTORIAL DE LOS 18 ÍTEMS DE LA BPRS

Factor Clínico	Ítems Origen	Rango	Dimensiones Psicopatológicas Evaluadas
1. Ansiedad y Depresión	Ítems 1, 2, 5, 9	4 - 28	Preocupación somática, ansiedad psíquica, sentimientos de culpa y ánimo depresivo
2. Anergia (Negativo)	Ítems 3, 13, 16, 18	4 - 28	Retraimiento emocional, enlentecimiento motor, embotamiento afectivo y desorientación
3. Pensamiento (Positivo)	Ítems 4, 8, 12, 15	4 - 28	Desorganización conceptual, grandiosidad, alucinaciones y contenido inusual del pensamiento
4. Activación	Ítems 6, 7, 17	3 - 21	Tensión motora, manierismos/posturas y excitación psicomotriz franca
5. Hostilidad y Susplicacia	Ítems 10, 11, 14	3 - 21	Hostilidad verbal/física, suspicacia/desconfianza y falta de cooperación

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN POBLACIÓN CLÍNICA ESPAÑOLA

Consistencia interna	Excelente fiabilidad psicométrica; alfa de Cronbach global $\alpha = 0.86 - 0.90$ en muestras de pacientes con psicosis aguda y esquizofrenia (Bobes et al., 2004).
Fiabilidad interobservador	Concordancia entre clínicos psiquiatras entrenados: coeficiente de correlación intraclase CCI = $0.81 - 0.89$ en puntuación total y $\kappa > 0.75$ por ítem individual.
Validez concurrente	Correlación positiva muy alta con la Escala de Síntomas Positivos y Negativos (PANSS, $r = 0.88 - 0.92$) y con la Impresión Clínica Global (CGI-S, $r = 0.78$).
Sensibilidad al cambio	Sensibilidad excelente para monitorizar la eficacia de antipsicóticos en ensayos clínicos; una reducción de $\geq 20 - 30\%$ define respuesta clínica terapéutica estandarizada.
Validez factorial	Los análisis factoriales confirman la replicabilidad de los 5 factores clínicos en muestras agudas y crónicas.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Escala de gravedad	Cada ítem se puntúa de 1 a 7: 1 = No presente ; 2 = Muy leve ; 3 = Leve ; 4 = Moderado ; 5 = Moderadamente grave ; 6 = Grave ; 7 = Extremadamente grave .
Puntuación directa global	Suma aritmética simple de los 18 ítems. Rango teórico posible: 18 a 126 puntos . (Nota: si se usa codificación 0 a 6, el rango es de 0 a 108 puntos).
Índices dimensionales	Se computan las medias o sumas de los 5 factores clínicos para tipificar el subtipo predominante: Positivo, Negativo, Afectivo o Agitado.
Regla de temporalidad	La evaluación se refiere a los síntomas y conductas observadas en los últimos 3 a 7 días precedentes a la entrevista.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntos (18-126)	Puntos (0-108)	Severidad Psicopatológica	Significación Clínica y Nivel Asistencial
18 - 30 puntos	0 - 12	Asintomático / Remisión	Sintomatología mínima o residual controlada; mantenimiento ambulatorio.
31 - 40 puntos	13 - 22	Psicopatología Leve	Leve descompensación; no compromete la vida comunitaria autónoma.
41 - 52 puntos	23 - 34	Psicopatología Moderada	Cuadro psicótico activo; requiere ajuste farmacológico o intensificación.
53 - 70 puntos	35 - 52	Psicopatología Grave	Brote psicótico agudo manifiesto; frecuente indicación de hospitalización.
71 - 126 puntos	53 - 108	Psicopatología Muy Grave / Extrema	Riesgo vital, agitación inmanejable o estupor catatónico; urgencia psiquiátrica.

PUNTOS DE CORTE Y CRITERIOS DE RESPUESTA EN ENSAYOS CLÍNICOS:

- **BPRS > 40 puntos (escala 18-126):** Criterio estándar de inclusión para episodios psicóticos activos.
- **Respuesta Terapéutica:** Reducción de al menos el 20 – 30% respecto a la puntuación basal tras 4-6 semanas de tratamiento antipsicótico.
- **Criterio de Remisión Sintomática:** Puntuación ≤ 3 (muy leve/ausente) en los ítems clave de pensamiento y afecto (ítems 4, 8, 12, 15) durante al menos 6 meses.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA EN DESCOMPENSACIÓN PSICÓTICA

Paso 1: Aplicación estructurada de la BPRS: Entrevista de 20 minutos con paciente y cuidadores.

Paso 2: Si BPRS Total $\leq$ 30 (Remisión): Mantener pauta antipsicótica de mantenimiento; planificar rehabilitación psicosocial.

Paso 3: Si BPRS 41 — 52 (Moderada): Verificar adherencia al antipsicótico oral (valorar paso a inyectable de liberación prolongada - ILP); titular dosis dentro del rango terapéutico.

Paso 4: Si BPRS $\geq$ 53 (Grave o Extrema):

- Valorar riesgo inminente de auto/heteroagresión (revisar ítems 10 Hostilidad y 17 Excitación).
- Si existe ideación paranoide refractaria o alucinaciones imperativas, proceder a ingreso en Unidad de Hospitalización Breve.

Paso 5: En Resistencia Terapéutica (fracaso de dos antipsicóticos a dosis plenas durante 6 semanas con BPRS $>$ 40): Indicación formal de iniciar titulación con Clozapina.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN HOSPITALIZACIÓN PSIQUIÁTRICA

Identificación: Varón de 28 años con diagnóstico de esquizofrenia paranoide de 4 años de evolución, trasladado a Urgencias por el 061 tras atrincherarse en su domicilio y amenazar a vecinos convencido de ser vigilado por drones militares.

Evaluación BPRS Inicial: Puntuación Total = **68 / 126** (Psicopatología Grave).

- Desglose por factores: Pensamiento/Positivo = 22/28 (Ítem 11 Susplicacia = 6, Ítem 12 Alucinaciones = 6 [voces continuas en tercera persona], Ítem 15 Contenido inusual = 6 [delirio persecutorio y de perjuicio]); Hostilidad = 15/21; Excitación motora = 5/7; Anergia = 7/28.

Intervención: Ingreso psiquiátrico en régimen cerrado; suspensión de risperidona por falta de adherencia previa e inicio de aripiprazol oral con rápida transición a formulación mensual inyectable (aripiprazol depot 400 mg). Psicoterapia focalizada en recuperación de insight y desescalada.

Reevaluación a las 3 semanas (previo al alta): La BPRS Total descendió a **28 / 126** (Remisión sintomática, reducción del 58%), cese de las órdenes alucinatorias y recuperación del vínculo terapéutico.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgo Psiquiátrico:

- **Alucinaciones Imperativas:** Voces de comando que ordenan atacar o suicidarse exigen contención física/farmacológica y vigilancia 24h.
- **Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM):** Rigidez motora aguda, hipertermia y diaforesis confusa; retirar antipsicótico y derivar a UCI.

Diagnóstico Diferencial:

- **Psicosis Primaria vs. Orgánica / Tóxica:** Descartar intoxicación por cannabis, amfetaminas, lupus o encefalitis anti-NMDA en primeros episodios.
- **Síntomas Negativos vs. Depresión:** EL embotamiento afectivo no cursa con dolor moral ni culpa (evaluar con Calgary CDS).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Overall, J. E., & Gorham, D. R. (1962). The brief psychiatric rating scale. *Psychological Reports*, 10(3), 799-812. <https://doi.org/10.2466/pr0.1962.10.3.799>
- Overall, J. E. (1988). The Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS): recent developments in instrumentation. In *Psychopharmacology: The third generation of progress* (pp. 743-748). Raven Press.
- Bobes, J., García-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3ª ed.). Ars Medica / Psiquiatría Editores.
- Leucht, S., Kane, J. M., Kissling, W., Dold, M., & Davis, J. M. (2005). What does the PANSS mean? *Schizophrenia Research*, 79(2-3), 231-238.